CURSO BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
RLL	APL	2	Jun 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
		1	Junio 01	EMISION

ÍNDICE

Primeros Auxilios

1. Actuación General ante un accidente
   1.1. Prevenir más accidentes
   1.2. Avisar a los Servicios Sanitarios
   1.3. Socorrer al accidentado
      1.3.1. Exploración Primaria (Signos Vitales)
         1.3.1.1. Conciencia
         1.3.1.2. Respiración
         1.3.1.3. Pulso
      1.3.2. Exploración Secundaria
   1.4. Prioridades de Actuación
2. Obstrucción de la Via Aérea
   2.1. Causas
   2.2. Actuación
      2.2.1. Consciente
      2.2.2. Inconsciente
   2.3. Técnicas
      2.3.1. Hemlich levantado
      2.3.2. Hemlich tumbado
      2.3.3. Posición lateral de seguridad
3. R.C.P. (Reanimación Cardio-Pulmonar)
   3.1. Sin respiración pero con pulso
   3.2. Sin respiración ni pulso
   3.3. Consejo de R.C.P. a politraumatizados o posible lesión medular
4. Hemorragia
   4.1. Clasificación según localización de la sangre al salir del vaso.
   4.2. Actuación
   4.3. Hermorragia externa
   4.4. Hemorragia interna
5. Consejos de lo que NO debemos hacer

PRIMEROS AUXILIOS

1. ACTUACIÓN GENERAL ANTE UN ACCIDENTE.

1.1. Prevenir más accidentes

1.2. Avisar a los servicios sanitarios

1.3. Socorrer al accidentado

1.1. PREVENIR

Es muy importante mantener la calma y, antes de actuar, hacer una evaluación rápida, detectando posibles peligros que todavía existan contra el accidentado, nosotros y para el resto de compañeros que puedan llegar.

1.2. AVISAR

Hay que tener presentes los pasos siguientes:

- Conocer los sistemas de comunicación y teléfonos principales.
  - Botiquín Intecsa Industrial:
    -
  - Bomberos .
  - Ambulancia.
  - Clínica.
  - Centro Coordinador de Ambulancias
- Informar de la localización exacta del accidente.
- Nº de accidentados y lesiones que tengan.
- Verificar que la información ha sido recibida correctamente.

1.3. SOCORRER

Antes de nada hay que explorar en busca de lesiones.

1.3.1. EXPLORACIÓN PRIMARIA (SIGNOS VITALES)

Son: conciencia, respiración y pulso.

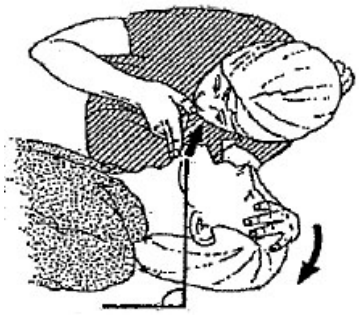
1.3.1.1. Conciencia: Se valora preguntando al accidentado cómo se encuentra y valorar la respuesta.

Existe para esta evaluación un test llamado “Escala de Coma de Glasgow”.

1. Apertura de ojos	2. Respuesta verbal	3. Respuesta motora
- Espontanea……....4 - Al hablarle……...3 - Al dolor……2 - Ninguna……..1 (1) indicar si los ojos están cerrados por edema o hematoma parpebral	Orientado……5 Confuso……...4 Inapropiada……3 Incomprensible……2 Ninguna……1	Obedece órdenes……..6 Localiza……...5 Retirada……..4 Decorticación (flexión)…..3 Descerebración (extensión)2 Ninguna……1

Se puntúan las respuestas y se suman. Cuanto mayor sea el número, mejor nivel de conciencia se tiene.

1.3.1.2. Respiración: Se comprueba apoyando nuestra oreja en la nariz o boca del lesionado y mirar físicamente el tórax de éste buscando movimientos de respiración.



1.3.1.3. Pulso: Se colocan los dedos índice y medio al lado de la nuez y se aprieta un poco buscando el pulso carótido que es el último que se pierde.

1.3.2. EXPLORACIÓN SECUNDARIA (Resto del Cuerpo)

Cuando están garantizados los signos vitales, buscaremos otras lesiones de cabeza a pies.

A) General: Aspecto general (color de la piel, postura en que se encuentra...)
B) Cabeza y cara
C) Extremidades superiores
D) Tórax

E) Abdomen

F) Extremidades inferiores

Durante la exploración buscaremos: hemorragias, fracturas abiertas, deformidades, heridas, contusiones...

1.4. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Son de atención preferente las paradas cardíacas / respiratorias y luego los que tengan hemorragias graves. Después, atender a las fracturas abiertas y/o heridas graves y por último los que tengan fracturas cerradas y/o heridas leves.

4. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA.

4.1. Causas

4.2. Actuación

4.2.1. Consciente

4.2.2. Inconsciente

4.3. Técnicas

4.3.1. Hemlich levantado

4.3.2. Hemlich acostado

4.3.3. Posición lateral de seguridad

2.1. CAUSAS

Puede ser causada por: comida, bebida o pérdida de conciencia donde la lengua pierde el tono y por gravedad obstruye el paso de aire hacia la tráquea.

2.2. ACTUACIÓN

Qué debemos hacer ante un caso de obstrucción:

2.2.1. Consciente:

1º Si está **consciente** y tose le dejamos hacer sin golpearle la espalda, hasta que él solo haya solucionado el problema.

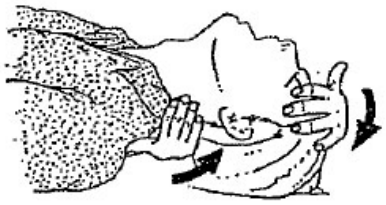
2º En caso de tos persistente y después de mucho rato, con signos de anoxia como azulamiento o enrojecimiento de la cara, se le aplicará la técnica de Hemlich (ver punto 2.3.1.)

2.2.2. Inconsciente: Pérdida de conciencia.

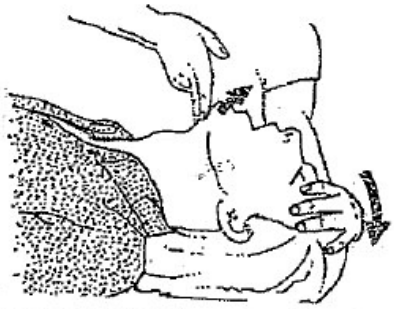
1º Comprobar signos vitales

2º Colocarlo en decúbito supino.

3º Maniobra de hiperextensión del cuello (en caso de no traumatizados) o de hiperextensión de mandíbula (en cualquier caso, traumatizados y no traumatizados).



Maniobra de hiperextensión del cuello



Maniobra de hiperextensión de mandíbula

4º Rastreo de la boca con el dedo. Se aguanta la boca abierta usando los dedos índice y gordo cruzados y con un dedo de la otra mano en posición de gancho se rastreará.

5º Aplicar la técnica Hemlich buscando la permeabilidad de las vías aéreas.

En caso de no observar ninguna variación, donde no haya respiración espontánea se procederá a insuflación boca a boca y se vigilará de que suba el tórax a nuestras insuflaciones. Si sigue la negativa, continuar con la técnica de Hemlich hasta que sea eficaz o lleguen recursos.

2.3. TÉCNICAS

2.3.1. Hemlich levantado.

Se realiza sólo con personas conscientes que no sean demasiado voluminosas para nosotros. Ejemplo: el afectado mide 190 cm y pesa 120 kg. en cambio, el socorrista mide 160 cm y pesa 60 kg.

En esta técnica nos colocamos detrás del afectado. Nuestros brazos pasan por debajo de las axilas del otro. Cerramos una mano y la apoyamos 4 dedos por encima del ombligo. Luego se coge el puño con la otra mano y se trata de empujar hacia arriba y adentro para que el diafragma provoque la expulsión del cuerpo extraño.

A veces hay que repetir varias veces para que sea efectivo.

Maniobra de Heimlich, de pie

2.3.2. Hemlich acostado.

Para personas demasiado grandes y conscientes o para inconscientes.

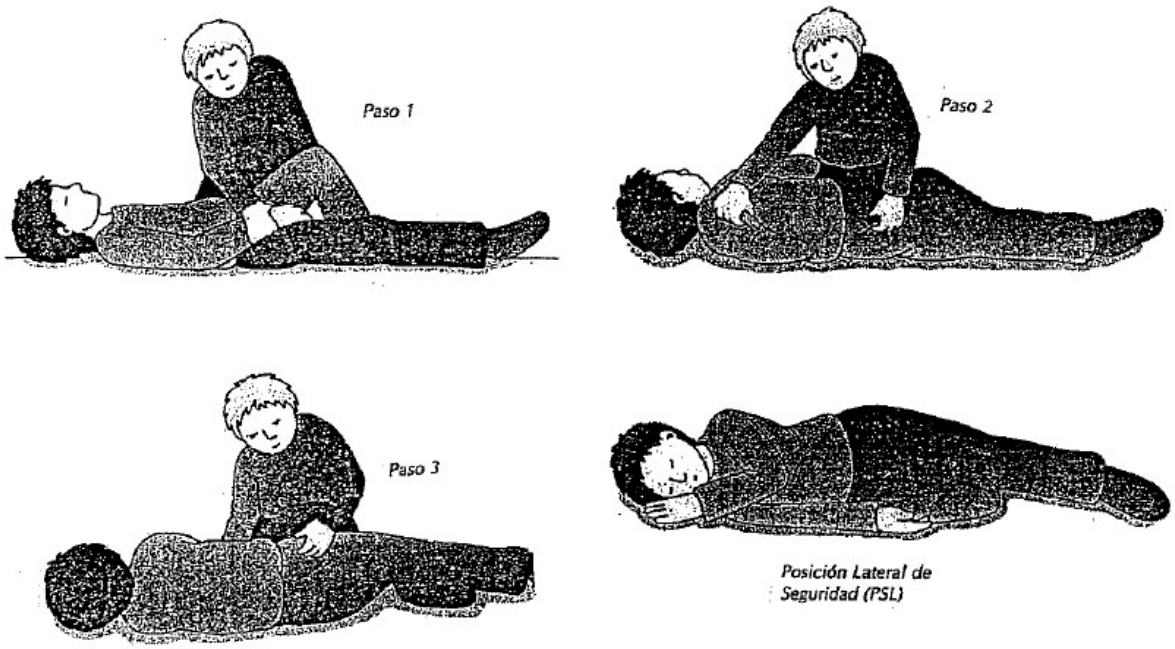
Se coloca el afectado boca arriba y nos colocamos montados a horcajadas a la altura de su cadera. Apoyamos el talón de una mano dos dedos por encima del ombligo y con la otra apoyada encima y con los brazos rígidos, empujamos con nuestro cuerpo hacia arriba y para adentro apretando el diafragma.

Método de Heimlich al suelo

- **Importante**: Todas estas maniobras se ejercen sobre el diafragma, no sobre el abdomen. No hacer nunca fuerza desviándose lateralmente hacia derecha o izquierda.
  Cuando ya **respire** y **esté inconsciente** dejarlo en **posición de seguridad** siempre que no sea traumatizado.

2.3.3. Posición lateral de seguridad.

Esta posición tiene por finalidad que los propios fluidos del lesionado no le obstruyan las vías respiratorias. Ejemplo: vómitos.



5. R.C.P. (REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR).

5.1. Sin respiración pero con pulso

5.2. Sin respiración ni pulso

5.3. Consejo de R.C.P. a politraumatizados o posible lesión medular.

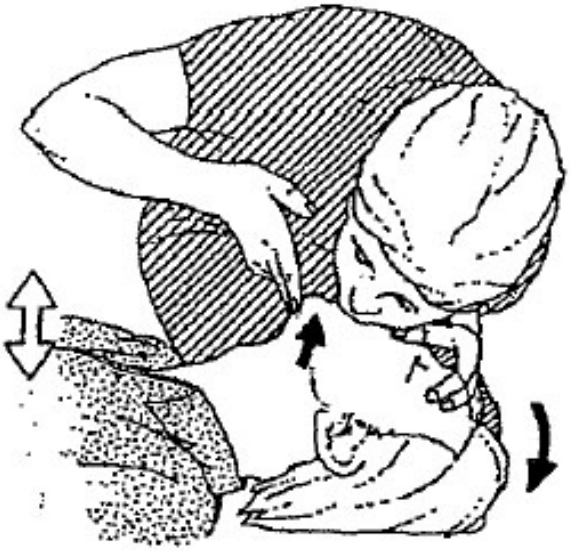
3. R.C.P. (REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR)

Ésta se ejerce después de que en la valoración primaria fallen la respiración, el pulso o las dos cosas.

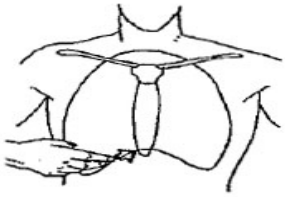
3.1. SIN RESPIRACIÓN PERO CON PULSO

Se le harán dos insuflaciones seguidas con espacio intermedio, esperando que baje su tórax y se vuelven a comprobar los signos vitales.

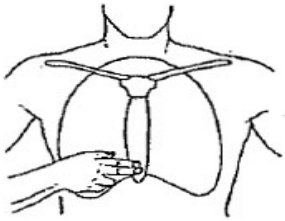
En caso de que continuase siendo negativo el resultado, el ritmo sería de 15 a 20 insuflaciones por minuto, o sea, una cada tres o cuatro segundos.



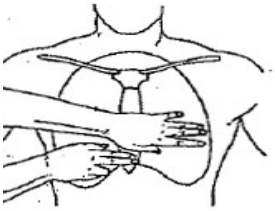
3.2. SIN RESPIRACIÓN NI PULSO

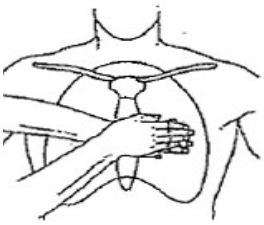


Le falla el pulso y la respiración:



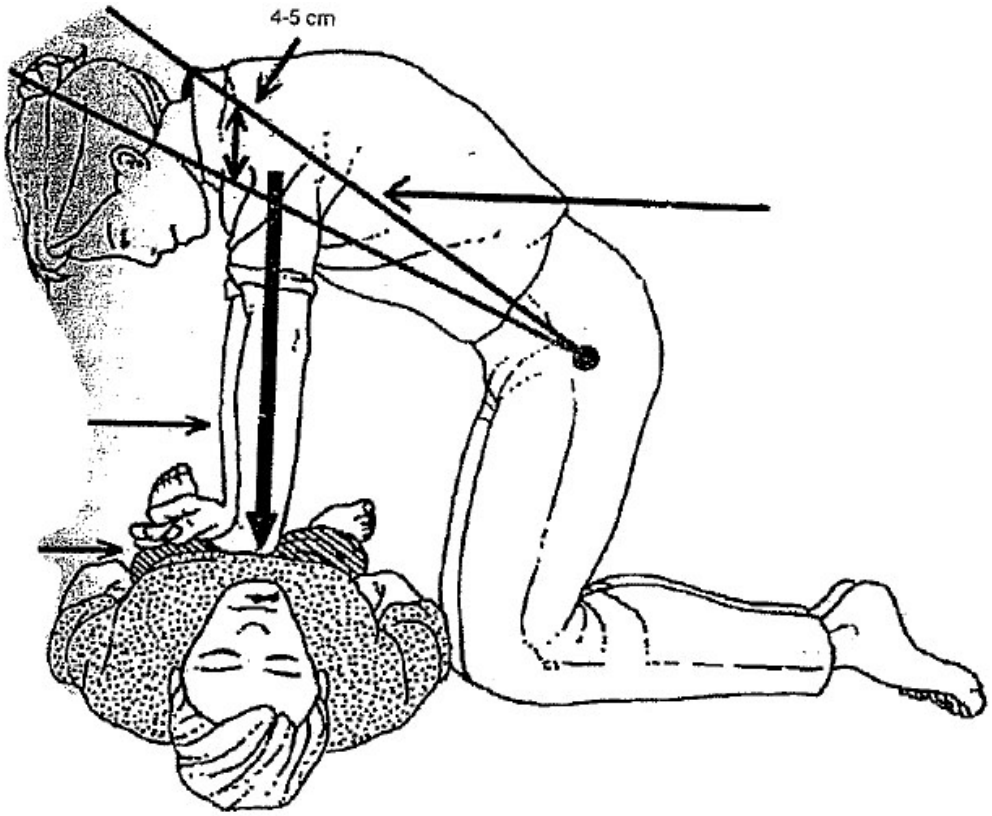
- Colocamos el accidentado boca ariba. Le despejamos, como ya sabemos, la vía respiratoria.
- Nos colocamos de rodillas al lado del accidentado y le buscamos la punta del esternón.
- La otra mano agarra la anterior, brazos en extensión y espalda recta.
- Subimos y bajamos el tórax del accidentado de 4 a 5 cm.
- El ritmo del masaje dependerá del número de socorristas. Así, en caso de uno sólo: ritmo de 2 insuflaciones iniciales y 15 masajes cardíacos.
- En caso de dos socorristas: 2 insuflaciones iniciales y el ritmo es de 5 masajes cardíacos por una insuflación.
- Después de cuatro ciclos seguidos se tienen que comprobar otra vez los signos vitales.
- En caso negativo, comprobamos cada cinco minutos.





3.3. CONSEJO DE R.C.P. A POLITRAUMATIZADOS O POSIBLE LESIÓN MEDULAR.

R.C.P. se realizará con movilización mínima, suavemente y a ser posible después de inmovilizar la columna.



6. HEMORRAGIAS.

6.1. Clasificación según localización de la sangre al salir del vaso.

6.2. Actuación

6.2.1. Hemorragia externa

6.2.2. Amputación

6.2.3. Hemorragia interna

4.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LOCALIZACIÓN DE LA SANGRE AL SALIR DEL VASO

a) Externa: A través de heridas
b) Interna: la sangre se vierte en el interior del cuerpo del individuo

4.2. ACTUACIÓN

4.2.1. Hemorragia externa

1º. Hacer presión sobre la herida con paños limpios y, si vemos que no es suficiente, sin quitar los primeros añadimos más encima.

2º. Si todavía no resulta, levantar la extremidad afectada por encima del corazón.

3º. Presionar arteria como indica el dibujo.

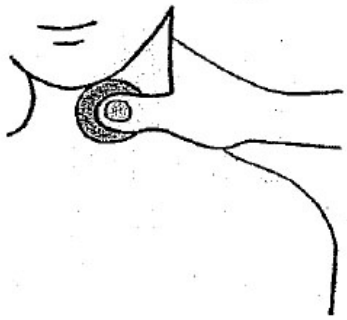


FIGURA 5
Compresión carótida

FIGURA 8
Compresión humeral

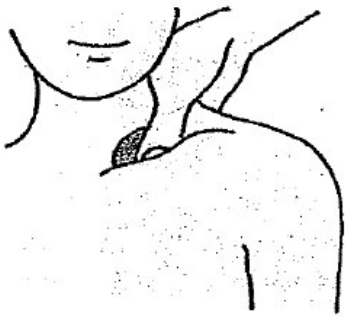


FIGURA 6
Compresión subclavia

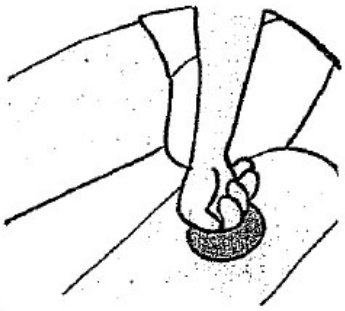


FIGURA 9
Compresión femoral

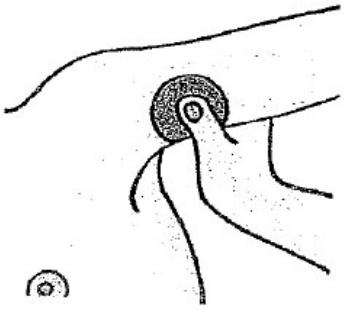
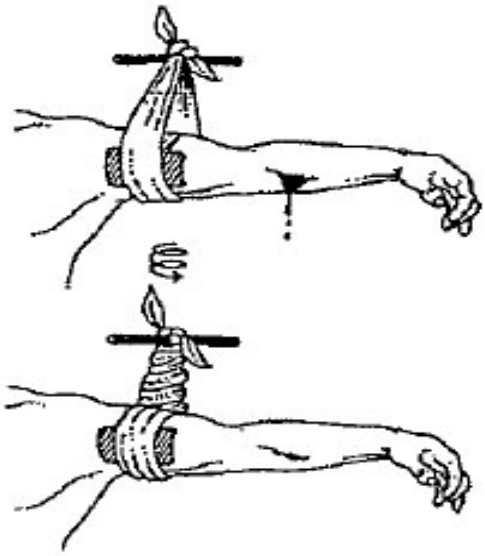


FIGURA 7
Compresión axilar

4º. Como última recurso, aplicar TORNIQUETE. Es la última opción ya que podemos matar la extremidad del lesionado. Normas para la correcta manipulación de éste:

a) Usar un trozo de ropa ancha (10 cm como mínimo) y almohadillar el punto de presión.
b) Se enroscará con la presión necesaria, no más y se colocará por encima de la lesión y donde pueda apretarse encima de una superficie dura y no articulada.
c) Se fijará el torniquete sin aflojarlo ni tocarlo anotando la hora en que se ha puesto.



4.2.2. Amputación.

1º Se aplica torniquete aunque no sangre dejándolo preparado por si sangrara de repente.

2º Se recoge la extremidad amputada y se envuelve con gasas empapadas con suero fisiológico. Se cierra en una bolsa de plástico. Ésta, por último, se introduce en otra bolsa con hielo dentro.

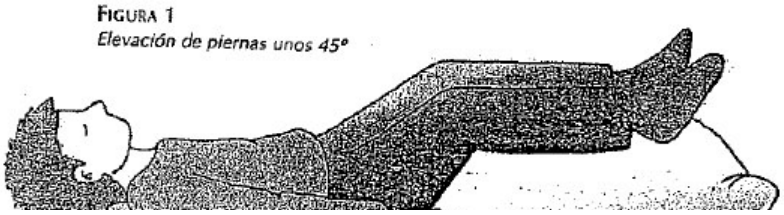
4.2.3. Hemorragia interna.

Cuando se recibe un golpe en abdomen o tórax, siempre hay que sospechar de hemorragia interna. Aparece palidez, pulso rápido, posición fetal...

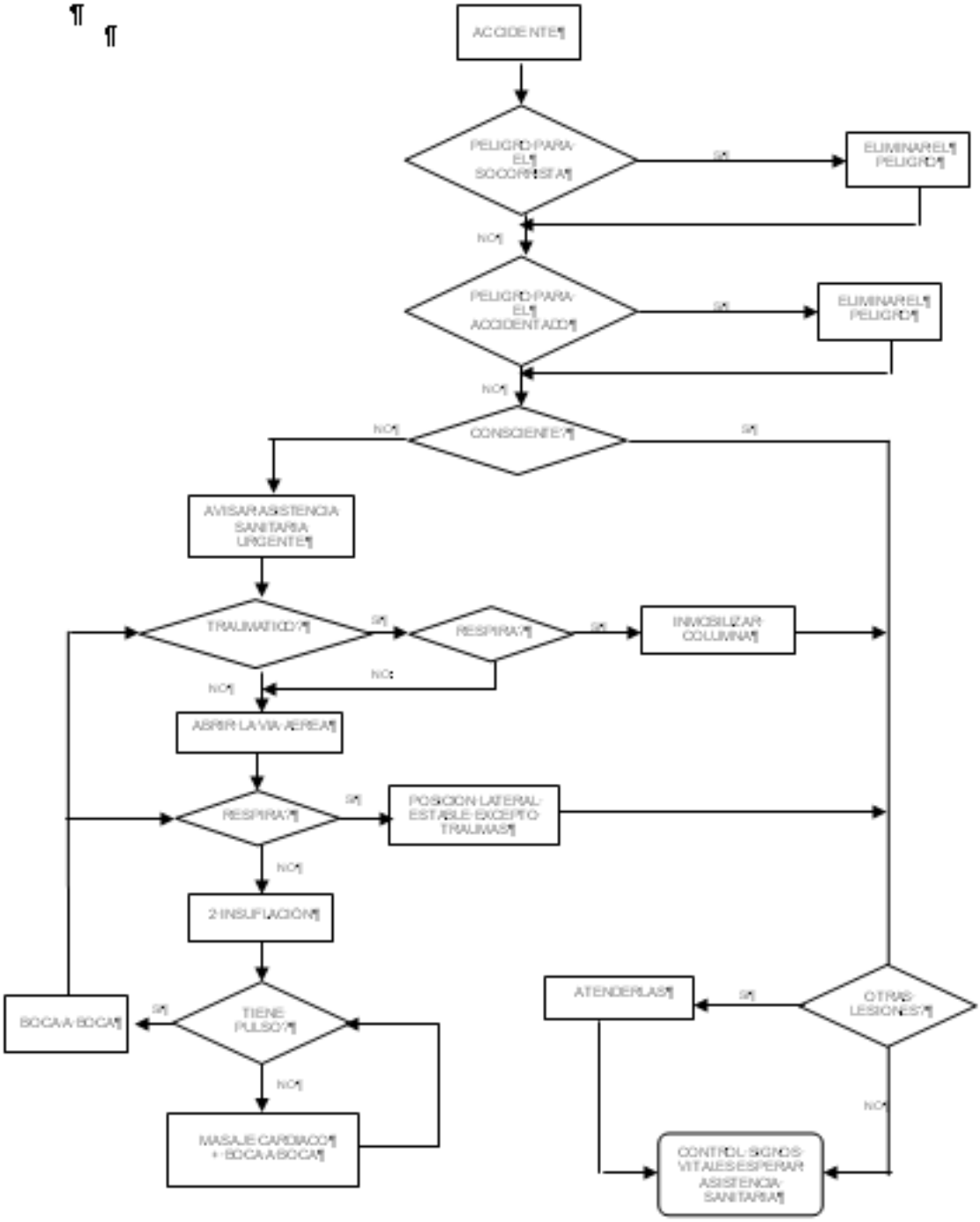
Actuación: Colocar piernas elevadas y tapar con una manta.

Ante un golpe torácico, incorporarle para que respire con más facilidad y envolverle con una manta.

FIGURA 1
Elevación de piernas unos 45º



5. **CONSEJOS DE LO QUE NO DEBEMOS HACER.**

- Dejar que se acerquen curiosos a la víctima.
- Sustituir al sanitario.
- Movilizar a un accidentado que no hemos visto cómo se lo hacía.
- Movilizar a un accidentado con posible traumatismo de columna sin inmovilizarlo antes.
- Usar la técnica de tracción de cuello a un traumatizado cervical.
- Manipular con las manos sucias cualquier herida o mucosa.

Esquema 1 os Auxilios